КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ

ДИАГРУПП

БАЙКАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

# Профессиональное общение врача с пациентом

Практические навыки по Калгари-Кембриджской модели



Лектор

Буянтуева Соелма Степановна

# Калгари-Кембриджская модель: карта консультации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Начало консультации | Сбор информации | Физикальное обследование | Разъяснение и планирование | Завершение консультации |

ДВЕ СКВОЗНЫЕ ЗАДАЧИ — НА ВСЕХ ЭТАПАХ КОНСУЛЬТАЦИИ

- 1. СТРУКТУРИРОВАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
- 2. ВЫСТРАИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ПАЦИЕНТОМ

# Начало консультации: три задачи

01

Подготовиться к разговору.

02

Установить первоначальный контакт.

03

Выяснить все поводы обращения
и договориться о плане приёма.



# Золотая минута: дайте пациенту договорить

**92** секунды

Средняя продолжительность свободного начального рассказа пациентов в конкретном исследовании.

**78%**

пациентов завершили рассказ в течение двух минут.



**ФАСИЛИТАЦИЯ** | «Угу» / «Продолжайте» / Пауза

- Langewitz et al., 2002. Результаты конкретного исследования, а не норматив продолжительности рассказа.

# Практический пример: договориться о плане приёма



ПАЦИЕНТ

«Я пришёл узнать результаты анализов.
И ещё меня беспокоит сильная усталость»



ВРАЧ

«Обсудим и анализы, и усталость.
Есть ли ещё что-то важное для вас сегодня?»



ПАЦИЕНТ

«Нет, это всё. Я бы хотел сначала поговорить об усталости»



ВРАЧ

«Хорошо, сначала обсудим усталость, затем результаты анализов»

После уточнения тем,
которые пациент хочет обсудить,
согласовать порядок их обсуждения.

# Пациент говорит не только словами



Взгляд и мимика.



Интонация и голос.



Паузы и молчание.



Поза и жесты.

**Не делайте вывод за пациента — уточните**

*«Я заметила, что вы замолчали. Хотите немного подумать или что-то обсудить?»*

# Одна жалоба — два способа расспроса

Учебная ситуация: пациент жалуется на боль в груди.

## УЗКИЙ РАСПРОС

«Какая боль — тупая или острая?»

«Куда-нибудь ещё боль отдаёт?»

Врач узнаёт конкретные характеристики боли, но пациент отвечает коротко.

## ОТКРЫТОЕ НАЧАЛО

«У вас боль в груди — расскажите мне о ней».

Пациент дополнительно рассказывает:

*Боль нарастала две недели. Есть отрыжка и кислый вкус во рту, после алкоголя становится хуже. Принимает ибупрофен от боли в суставах. Упоминает сложные личные обстоятельства.*

Открытый вопрос помогает получить сведения, о которых врач мог не догадаться спросить.



# Осмотр тоже требует коммуникации

01 Перед осмотром объясните, что собираетесь делать и почему.

02 Спросите согласие, учитывайте комфорт и приватность пациента.

03 По мере необходимости сообщайте о следующем действии.

# Совместное принятие решений




01 Обозначить клиническую задачу и варианты.

02 Обсудить пользу, риски и ограничения.

03 Выяснить предпочтения пациента.

04 Согласовать дальнейшие действия.

> *«Я предлагаю этот вариант, потому что... Как вы к нему относитесь?»*

# SPIKES: шесть шагов трудного разговора

**S** 01 SETTING

Подготовить условия разговора.

**P** 02 PERCEPTION

Выяснить понимание ситуации пациентом.

**I** 03 INVITATION

Уточнить запрос на информацию и её подробность.

**K** 04 KNOWLEDGE

Сообщать понятно и постепенно.

**E** 05 EMOTIONS / EMPATHY

Откликнуться на переживания.

**S** 06 STRATEGY AND SUMMARY

Обсудить план и подвести итоги.

- Baile et al., 2000 · исходный контекст — онкология

# Дайте место реакции пациента

Не спешите заполнять молчание.

- Замечайте реакцию и откликайтесь с сочувствием
- Не давайте необоснованных обещаний.
- Продолжайте разговор, учитывая состояние и готовность пациента.

*«Что сейчас для вас самое трудное?»*

# Профессиональное общение — это навык, который можно развивать.

Что вы сделаете иначе уже на следующем приёме?

01 Дайте пациенту высказаться.

02 Узнайте, что его действительно волнует.

03 Замечайте эмоции и невербальные сигналы.

04 Объясняйте просто и проверяйте понимание.

05 Завершайте консультацию понятным планом.

**Хорошая коммуникация — часть качественной медицинской помощи**

